

Os consentimentos da Be4Hope

Onde a plataforma pede aceite, autorização ou consentimento: em que tela, de qual perfil, com que propósito e, principalmente, **o que cada um destrava no sistema.**

LEVANTAMENTO · lido no código

01/10/2026

código da main 6065964 (= produção)

ADR-0007 · ADR-0021 · ADR-0029

CFM-01 · LGPD-01 a 05

6

aceites ou autorizações
gravados no banco

7

funcionalidades que só
existem com um deles

11

lugares onde algum aceite
aparece, nos três perfis

2

consentimentos
desligados em produção,
de propósito

RESUMO EM UMA PÁGINA

- A plataforma tem **três consentimentos de verdade** (o titular diz sim a uma finalidade, e isso fica gravado com versão e data): a **consulta por vídeo**, o **resumo automático por IA** e o **compartilhamento com a Greens**. Ao lado deles há **três autorizações** que também ficam gravadas: a **procuração ANVISA** assinada pelo paciente e o **Google Agenda** e o **Mercado Pago** conectados pelo médico.
- Juntos, os seis destravam **sete funcionalidades**: entrar na consulta por vídeo, transcrever e resumir a consulta, enviar o cadastro à Greens, avisar a Greens da receita e da ANVISA, a Be4Hope representar o paciente na ANVISA, criar o Google Meet da consulta e o paciente agendar com o médico.
- Os dois consentimentos da teleconsulta estão desligados em produção** até o Jurídico revisar os textos e alguém preencher a razão social, o CNPJ, o encarregado (DPO) e o prazo de guarda. O de IA desliga e a consulta segue. O de vídeo é o problema: **pela leitura do código, o paciente fica sem botão para entrar na consulta** (§6, achado 1).
- Das **três finalidades** do compartilhamento com a Greens, **só uma destrava algo** (o retorno à Greens). A "avaliação médica" diz na tela *"sem isto não conseguimos agendar a sua consulta"*, e **nada no sistema faz isso**. Texto que promete o que o sistema não faz é o que a LGPD chama de enganoso (LGPD-02).
- O **"Li e concordo"** do cadastro em /registrar-se é só visual: não é gravado, e quem entra **pelo Google** nem passa por ele.

1. Como ler este levantamento

Cada item foi achado no código por busca ampla (consentimento, aceite, autorizo, termo, concordo, ciente, OAuth, permissão do navegador) e depois **lido** no arquivo. Os pontos mais sérios foram reconferidos linha a linha antes de entrar aqui. O código lido é o da **main** em **6065964**, que é o que está em produção.

classe	o que significa	quantos
consentimento	o titular dos dados diz sim a uma finalidade. Fica gravado quem, quando e a que versão do texto , e pode ser retirado	3

autorização gravada	assinatura ou conexão de conta que fica registrada e destrava algo, mas não é consentimento LGPD sobre dado de saúde (procuração, OAuth)	3
aceite só na tela	caixa, aviso ou frase de concordância que não grava nada	5
permissão do navegador	microfone, câmera e tela: quem pergunta é o navegador, não a plataforma	3
ato registrado	decisão humana gravada que não é aceite: a revisão da IA pelo médico (D0-29) e a emergência médica	2

O que não está aqui, porque não foi medido: o valor real das chaves de ambiente em produção (§5) e quantas linhas existem hoje em cada tabela. Isso só o banco e o servidor respondem, e só o Davi ou o Diniz alcançam.

2. O mapa, por perfil e por tela

Paciente • 7 lugares

- **Antes de entrar na teleconsulta:** autorização da consulta por vídeo e do resumo por IA, uma abaixo da outra
/paciente/teleconsulta/[roomId]
- **Cadastro por link, etapa "Autorização":** compartilhamento com a Greens, três caixas desmarcadas
/cadastro/[token]
- **Menu Configurações > Privacidade:** revê e retira o compartilhamento
/paciente/privacidade
- **ANVISA:** o bloco "o que faltou autorizar" e a assinatura da procuração
/paciente/anvisa
- **Criar conta:** "Li e concordo" (só na tela)
/registrar-se
- **Chamada de atendimento:** aviso antes de mostrar a tela (só na tela) e as permissões do navegador
chamada da ADR-0029
- **Termos, Política e Acesso Solidário:** concordância declarada no texto, sem registro
/termos-de-uso • /politica-de-privacidade • /programa-acesso-solidario

Médico • 3 lugares

- **"Pronto para iniciar?":** a tela de abertura da teleconsulta: o aceite do médico para o resumo por IA
GlobalTeleconsultaHost, em toda a área do médico
 - **Perfil:** conectar o Google Agenda
/medico/perfil
 - **Pagamentos > Configuração:** conectar o Mercado Pago
/medico/pagamentos/config
- E a **revisão humana da IA** (anamnese e painel lateral da teleconsulta), que é ato registrado e não aceite.

Admin • 1 lugar

- **ANVISA > Pedidos de atendimento:** o botão **Ativar**, que libera para o paciente a procuração "Be4Hope faz por mim" (D0-77)
/admin/anvisa
- Nenhuma tela do admin ou do médico mostra os consentimentos do paciente. Só o próprio paciente os vê, em Privacidade. A Greens recebe o registro dentro do envio do cadastro.

3. Os três consentimentos

C1 · Autorização para consulta por telemedicina

CFM-01 · CFM 2.314/2022, Art. 15

Propósito	O paciente autoriza que a consulta aconteça a distância e que sua imagem, voz e dados de saúde sejam transmitidos ao médico. A norma do CFM exige essa autorização, e diz que ela faz parte do prontuário.
Quem aceita	Só o paciente . O médico não aceita nem vê o estado na tela dele.
Onde	Na tela antes de entrar na sala, acima do botão "Entrar na Consulta". A recusa é dita como direito: <i>"A recusa não impede seu atendimento: ela apenas impede que ele aconteça por vídeo"</i> .
Destrava	A entrada do paciente na consulta por vídeo . Sem o aceite, o botão fica desabilitado com o texto "Autorize acima para entrar". A conferência está só no navegador : nenhuma rota do servidor confere o aceite antes de deixar o paciente na sala.
Exceção	Emergência médica , a única que a norma admite: o médico declara, com motivo de pelo menos 10 caracteres, e o aceite fica dispensado e registrado. A função existe e nenhuma tela a chama .
Grava	quem, quando e a versão do texto, na própria teleconsulta. Não há como retirar : não existe campo nem função de revogação.
Em produção	desligado, e trava a entrada O texto é rascunho e o portão de produção está fechado. Ver §6, achado 1.

lib/lgpd/consentimento.ts:79-105 · app/_actions/consentimento-teleconsulta.ts:197-301 · components/teleconsulta/Consentimento.tsx:146-226 · app/(paciente)/paciente/teleconsulta/[roomId]/page.tsx:353-375 · lib/auth/escopo-sala.ts:129-132

C2 · Autorização para o resumo automático da consulta (IA)

LGPD-05 · LGPD art. 11, I

Propósito	Transformar o que foi falado em resumo clínico escrito. O áudio vai ao Google Speech-to-Text e o texto ao Gemini , os dois com servidores fora do Brasil. O áudio não é guardado , e o texto passa por uma máscara de CPF, RG, telefone e e-mail antes de ir ao Gemini. A máscara só pega formatos fixos: telefone sem parênteses, RG sem pontos e número por extenso passam (<code>transcrever/route.ts:194-199</code>). O texto da tela diz tudo isso, inclusive que o áudio vai sem essa remoção.
Quem aceita	Paciente e médico, os dois . Cada um vê se o outro já aceitou. O admin não aceita.
Onde	Paciente: na mesma tela antes de entrar, abaixo da C1. Médico: na tela "Pronto para iniciar?".
Destrava	Gravar o áudio, transcrever e gerar o resumo . Aqui o portão está no servidor : a rota de transcrição responde 403 sem os dois aceites na versão atual. É opcional: a consulta acontece sem ele , e o médico escreve à mão.
Grava	os dois aceites (quem e quando), a versão do texto e a revogação. A função de retirar existe, e nenhuma tela a chama .
Em produção	desligado, como planejado A tela mostra "Resumo automático indisponível" e a consulta segue.

lib/lgpd/consentimento.ts:118-142 · app/_actions/consentimento-teleconsulta.ts:99-176 · app/api/teleconsulta/transcrever/route.ts:44-51 · components/teleconsulta/GlobalTeleconsultaHost.tsx:218,374,555-578

C3 • Compartilhamento entre Be4Hope e Greens Corp

LGPD-05 • ADR-0021 D-02 • versão 2026-09-10.v1

- Propósito

O paciente autoriza o compartilhamento de seus dados e documentos com a Be4Hope, e que a Be4Hope informe à Greens os documentos que emitir. O texto veio do formulário da Greens, a pedido do dono em 10/09.
- Quem aceita

Só o **paciente**, e só ele vê.
- Onde

Três telas, com o mesmo componente: a etapa "Autorização" do cadastro por link (todo mundo que abre o link), o menu **Privacidade** (rever e retirar) e o bloco "o que faltou autorizar" da tela ANVISA (para quem veio da Greens ou do WhatsApp). As caixas nascem **desmarcadas**, e cada finalidade diz o que acontece se recusada.
- Grava

uma linha por finalidade, com a versão, o idioma, o **texto exato lido**, a data e a tela de origem (`cadastro_por_link`, `painel_privacidade`, `tela_anvisa`). Retirar só marca a data, sem apagar.
- É pedágio?

Não. O cadastro conclui com as três caixas vazias.

finalidade	a tela diz, se recusar	o que destrava de fato
Retorno ao parceiro <code>retorno_ao_parceiro</code>	"O seu pedido na Greens não avança sozinho: você levaria os documentos."	destrava 2 o envio do cadastro com os documentos à Greens, e os avisos de receita emitida e ANVISA aprovada. O envio relê o consentimento no momento de sair. Se foi retirado, o envio é cancelado e não se repete.
Apoio na ANVISA <code>apoio_anvisa</code>	"Você continua podendo pedir a autorização por conta própria."	nada só decide se o bloco "o que faltou autorizar" aparece na tela ANVISA. Não condiciona procuração nem formulário.
Avaliação médica <code>avaliacao_medica</code>	"Sem isto não conseguimos agendar a sua consulta."	nada, e a tela promete nenhum portão lê esta finalidade. O agendamento acontece igual. Ver §6, achado 3.

lib/parceiros/consentimento.ts:28-105 • db/schema/consentimentos.ts • components/paciente/ConsentimentoDoCompartilhamento.tsx • lib/parceiros/pode-transferir.ts:28-46 • lib/parceiros/consentimento-ainda-vale.ts:43-47 • lib/parceiros/enviador.ts:196-205

4. As três autorizações gravadas

A1 • Procuração específica ANVISA (DocuSign)

ADR-0029 • D0-77

Propósito	O paciente autoriza a Be4Hope a fazer o processo da ANVISA em nome dele ("Be4Hope faz por mim").
Quem	Dois passos de dois perfis. O paciente pede o atendimento com suporte, o admin clica em Ativar , e só então o paciente vê e assina a procuração no DocuSign, dentro da própria tela.
Destrava	a representação : o checklist ganha a procuração e o laudo, o PDF da procuração pode ser gerado, e, com a assinatura, o checklist se completa e libera "Confirmar Envio à ANVISA". Nada sai sozinho para a ANVISA: quem protocola é o admin.
Grava	o pedido, quem ativou e quando, o estado da assinatura e o PDF assinado, com auditoria.
Em produção	ativo Provado por Davi em 30/09. O ambiente do DocuSign (sandbox ou produção) não foi medido.

app/_actions/pedido-atendimento-assistido.ts:118-297 • lib/anvisa/pedido-de-atendimento.ts:52-82 • app/(paciente)/_actions/anvisa.ts:229-438 • app/api/anvisa/procuracao/route.ts:88-93

A2 • Google Agenda

médico • 0Auth

Onde	Perfil do médico, "Conectar Google Calendar".
Destrava	o evento com Google Meet criado sozinho quando a consulta é paga. Com ele a consulta fica <i>confirmada</i> ; sem ele, <i>agendada</i> e sem Meet. Não bloqueia a agenda.
Grava	o token de acesso no cadastro do médico.

lib/integrations/google-calendar/index.ts:70-81 • app/api/auth/google/callback/route.ts • lib/agendamento/confirmar-consulta-paga.ts:151-175

A3 • Mercado Pago

médico • 0Auth

Onde	Pagamentos > Configuração.
Destrava	o paciente agendar e pagar com aquele médico. Só trava se a chave <code>MERCADOPAGO_BLOQUEIO_AGENDAMENTO_ATIVO</code> estiver em ativo ; o valor em produção não foi medido.
Grava	a conta conectada, com a credencial cifrada (ADR-0024).

lib/mercadopago/conta.ts:87-219 • app/(public)/_actions/agendamento.ts:147,1059

5. O que cada um destrava: as sete funcionalidades

Esta é a pergunta central. Cada linha é uma funcionalidade que **não existe** sem o aceite ou a autorização à esquerda. O estado à direita é o de produção, como o código o decide.

1

C1 • consulta por vídeo

paciente, ou emergência declarada

→ o paciente **entra na teleconsulta** por vídeo

travado

2

C2 • resumo por IA

paciente e médico, os dois

→ gravar o áudio, **transcrever** e gerar o **resumo clínico**

desligado

- | | | | |
|---|---|---|---------|
| 3 | C3 · retorno ao parceiro
paciente, mais a chave de ambiente | → enviar o cadastro e os documentos à Greens | a medir |
| 4 | C3 · retorno ao parceiro
paciente | → avisar a Greens de receita emitida e ANVISA aprovada | a medir |
| 5 | A1 · procuração ANVISA
admin ativa, paciente assina | → a Be4Hope representar o paciente na ANVISA | ativo |
| 6 | A2 · Google Agenda
médico | → criar o Google Meet e confirmar a consulta paga | a medir |
| 7 | A3 · Mercado Pago
médico, mais a chave de ambiente | → o paciente agendar e pagar com aquele médico | a medir |

E O QUE NÃO DESTRAVA NADA

- **Avaliação médica e apoio na ANVISA**, duas das três finalidades da C3: são gravadas e nenhuma funcionalidade depende delas.
- **"Li e concordo"** do `/registrar-se`: trava só o botão do formulário, e não o do Google.
- **Revisão humana da IA**: grava quem decidiu e o que decidiu, inclusive quando diverge. De propósito, nenhuma prescrição depende dela: *"não há caminho de um clique"* (proibição nº 2 do projeto).

O QUE SÓ A PRODUÇÃO RESPONDE

O código diz **como** cada portão decide. O **valor** que ele lê vem do ambiente do servidor, e por isso quatro estados acima ficam como "a medir":

- `PARCEIRO_TRANSFERENCIA_ATIVA`: o `deploy.yml` diz "ligada por decisão do dono em 11/09/2026"; a ADR-0026, de 23/09, diz "ela continua fora". **As duas fontes divergem.**
- `MERCADOPAGO_BLOQUEIO_AGENDAMENTO_ATIVO`, se o Google está configurado, e se o endereço e o segredo da Greens estão no servidor (sem eles, os avisos de receita e ANVISA não saem).
- Se já existe alguma teleconsulta com a C1 gravada, ou alguma linha na tabela de consentimentos (a ADR-0022 mediu zero, numa data anterior).

6. O que o levantamento achou

Nada abaixo foi corrigido. A regra do projeto é **catalogar com o perigo medido** e corrigir só com autorização, em trabalho próprio. Os achados entraram no `docs/04-LISTA-DE-AFAZERES.md` como Itens 67 a 73.

ACHADO 1 · ITEM 67 · O MAIS GRAVE

Pela leitura do código, em produção o paciente não consegue entrar na consulta por vídeo. O portão de produção dos consentimentos está fechado de propósito, porque o texto é rascunho. A caixa da C1 então mostra "Consulta por vídeo indisponível" e não pede aceite. Mas o botão "Entrar na Consulta" continua esperando esse aceite, e fica desabilitado com "Autorize acima para entrar". A pessoa lê "autorize acima" e, acima, não há o que autorizar. A saída prevista em norma, a emergência, não tem botão.

Não foi medido. Só produção diz se há consultas por vídeo acontecendo, ou se elas acontecem por outro caminho (o Google Meet da A2). Essa é a primeira pergunta para o Davi. `Consentimento.tsx:163,213` · `page.tsx:368-375` · `consentimento.ts:164,191-196`

#	achado	o que acontece, e para quem	perigo
2 68	O aceite da IA libera o navegador do médico antes do paciente aceitar	Ao aceitar, a tela avisa "liberado" sem conferir o outro lado, e não relê depois. O navegador do médico pode começar a gravar sem o aceite do paciente, ou não gravar depois que ele aceita. O servidor continua barrando o envio , então nada é transcrito. Hoje está desligado em produção.	médio
3 69	"Avaliação médica" promete o que o sistema não faz	A tela diz que sem ela "não conseguimos agendar a sua consulta", e nada no sistema condiciona o agendamento a ela. O bloco "o que faltou autorizar" ainda mostra as três caixas, embora só confira duas. É o tipo de informação que pode anular o consentimento (<code>LGPD-02</code>). Corrigir é decidir: implementar o efeito ou mudar o texto, e mudar o texto exige versão nova.	médio
4 70	"Li e concordo" não é gravado, e o Google pula	Não fica registrado quem aceitou os Termos e a Política, nem qual versão . Quem cria a conta pelo botão do Google não passa pela caixa. Os Termos dizem que o "uso continuado" é aceite, e nada prova isso.	médio
5 71	A conexão do Google Agenda não confere quem está conectando	A rota de retorno do Google grava o token no médico cujo id vem na própria URL, sem conferir a sessão nem uma assinatura. Quem souber o id de um médico e montar a URL pode ligar a própria agenda Google ao cadastro dele, e os Meets das consultas dele passam a nascer nessa agenda.	alto
6 72	A procuração pode ser "cumprida" sem DocuSign, e o retorno do DocuSign não é assinado	O retorno automático do DocuSign aceita qualquer chamada: a validação de assinatura é um <code>TOD0</code> . E o envio de documento da ANVISA aceita qualquer tipo, inclusive <code>procuracao_especifica</code> : subir um arquivo qualquer marca a procuração como enviada. A tela ainda sugere "baixe, assine e envie".	alto
7 73	Retirar e emergência existem sem tela, e há sobras antigas	Não há botão para o paciente retirar a autorização da IA, nem para o médico declarar emergência. A C1 nem tem como ser retirada. Duas colunas antigas (<code>consentimento_lgpd</code> , <code>consentimento_obtido</code>) não decidem nada. E a ADR-0007 ainda diz que a tela da C1 e a emergência não existem, e as duas existem.	baixo

JÁ CATALOGADOS ANTES, E QUE ESTE LEVANTAMENTO REENCONTROU

- **Item 61:** a tela do paciente na teleconsulta liga uma gravação local sem consentimento, que não sai do navegador.
- O pedido de envio à ANVISA não confere de quem é a autorização (docs/03 , achado do confirmarEnvioAnvisa).
- Os textos C1 e C2 aguardam o Jurídico, o CNPJ, o encarregado e o prazo de guarda (handoff, §4).

7. O que não existe na plataforma

o quê	o que o código mostra
Banner de cookies	Não há analytics, pixel nem rastreamento no código. A Política diz que não usa cookies de rastreamento, e o código confirma. Se o banner é exigido mesmo assim, é pergunta para o Jurídico: não pesquisei a norma.
Opt-in de comunicação	Não há preferência de comunicação nem descadastro. O Brevo envia e-mails (lembretes de recompra, avisos) sem conferir opt-in. O ChatPro não envia por iniciativa da plataforma: só responde ao bot.
Triagem pública e e-book	A triagem recolhe dado de saúde com a frase "protegidas pela LGPD", sem caixa, e copia as respostas (CPF, diagnóstico, medicamentos, renda) para uma planilha Google (lib/integrations/google-sheets/index.ts). O e-book grava nome, e-mail e telefone sem consentimento. A base legal é pergunta para o Jurídico.
Consentimento do responsável por menor	A Política exige "consentimento expresso do responsável legal". Nenhum registro desse consentimento foi achado.
Aceite na receita ou no pagamento	Nenhum. A assinatura ICP-Brasil ainda é stub, e o pagamento mostra só o texto de cancelamento.
Aceite na chamada de atendimento	Nenhum, de propósito: nada é gravado (ADR-0029). Há o aviso antes de mostrar a tela e as permissões do navegador. O microfone é pedido ao entrar; a câmera começa desligada.

8. Próximos passos, e de quem é cada um

1. **Medir o achado 1** (Davi ou Diniz, na VPS): se há teleconsultas por vídeo acontecendo em produção. Eu preparo o bloco de leitura, testado num banco descartável, quando pedirem.
2. **Decidir o desfecho do achado 1** (dono): esperar os textos revisados ou destravar a entrada por vídeo enquanto isso. É regra de negócio e norma (CFM-01), e não se presume.
3. **Jurídico:** revisar C1 e C2, fornecer razão social, CNPJ, encarregado (DPO) e prazo de guarda, e dizer a base legal da triagem pública e do e-book.
4. **Decidir a "avaliação médica"** (dono): implementar o efeito que a tela promete ou reescrever o texto com versão nova.
5. **Autorizar a correção dos achados 5 e 6**, os de perigo alto, cada um em trabalho próprio e com guarda.
6. **Alinhar a fonte da chave de transferência:** o deploy.yml e a ADR-0026 dizem coisas opostas.

Escrito por Claude Code Be4Hope em 01/10/2026, a pedido do Davi. Levantamento por leitura do código da main 6065964 ; nada foi executado contra produção. Os fundamentos citam os IDs do docs/02-CATALOGO-DE-REGRAS.md . O art. 8º §5º da LGPD (revogação "a qualquer momento") é citado pelo código e ainda não tem ID próprio no catálogo. Fonte deste PDF: docs/levantamentos/LEVANTAMENTO-DOS-CONSENTIMENTOS.html .